

초고령자의 삶의 만족도와 우울에 영향을 미치는 라이프스타일 요인: 고령화연구패널조사(KLoSA) 분석

김아람*, 박지혁**

*연세대학교 초고령사회 뉴노멀 라이프스타일 연구소 박사후연구원

**연세대학교 소프트웨어디지털헬스케어융합대학 작업치료학과 교수

국문초록

목적: 본 연구는 국내 초고령자를 대상으로 삶의 만족도 및 우울과 라이프스타일(신체활동, 식습관, 참여빈도, 참여다양성) 간의 상관관계를 확인하고, 삶의 만족도와 우울에 영향을 미치는 라이프스타일 요인을 분석 및 확인하고자 하였다.

연구방법: 본 연구의 독립변수는 라이프스타일 요인으로 신체활동, 규칙적 식습관, 참여빈도, 참여다양성이었으며, 종속변인은 삶의 만족도와 우울이었다. 분석을 위해 SPSS를 이용해 상관관계분석 및 다중회귀분석을 실시하였다.

결과: 다중회귀분석을 통해 삶의 만족도에 영향을 미치는 요인으로는 참여빈도($t = 6.262, p < 0.001$)와 규칙적 식습관($t = 4.627, p < 0.001$)이 통계적 유의성을 가지는 것으로 확인되었으며, 우울에 영향을 미치는 요인으로는 참여빈도($t = 6.540, p < 0.001$)와 규칙적 식습관($t = 4.061, p < 0.001$)이 통계적 유의성을 가지는 것으로 확인되었다.

결론: 본 연구를 통하여 국내 초고령자의 삶의 만족도와 우울에 영향을 주는 라이프스타일 요인을 확인하였다. 따라서 본 연구 결과를 토대로 초고령자의 삶의 만족도와 우울 개선을 위해서는 라이프스타일을 기반으로 하는 다면적 중재 프로그램이 필요하다.

주제어: 라이프스타일, 삶의 만족도, 우울, 초고령자

1. 서론

세계보건기구(World Health Organization, WHO)는 인간의 수명을 평균수명과 건강수명으로 구분하고 있

다. 단순히 얼마나 오래 살았는가를 의미하는 평균수명과 다르게, 건강수명은 질병의 경중에 따라 활동에 참여할 수 있는가를 의미한다(May et al., 2015). 즉, 건강수명은 삶의 질이라고 할 수 있는 건강상태를 평균수명에

ORCID: Kim, Ah-Ram, <https://orcid.org/0000-0003-2726-5239>

Corresponding author: Park, Ji-Hyuk (otscientist@yonsei.ac.kr/Dept. of Occupational Therapy, College of Software and Digital Healthcare Convergence, Yonsei University)

Received 20 September 2023; Accepted November 7 2023

This work was supported by the Ministry of Education of the Republic of Korea and the National Research Foundation of Korea (NRF-2021S1A3A2A02096338).

This work was supported by the ICONS (Institute of Convergence Science), Yonsei University.

반영시킨 것으로, 수명의 질적인 측면을 의미한다(Park et al., 2019). 최근 전 세계적으로 노령인구의 증가 및 고령화로 인해, 평균수명뿐만 아니라 건강수명을 중요시하는 경향이 두드러지고 있다(Lee et al., 2012).

WHO는 건강수명과 삶의 질 향상을 위해서는 건강한 라이프스타일이 필요하다고 강조하고 있다(WHO, 2022). 라이프스타일이란 개인의 건강상태에 큰 영향을 미치는 요인 중 하나이며(Ziglio et al., 2004), 적절한 신체활동, 다양한 활동참여 및 건강한 식습관 등을 포함한다(King et al., 2009). 이러한 라이프스타일은 당뇨와 심혈관계질환과 같은 만성질환을 비롯하여 주요 질병의 유병률을 낮추고 사망률을 낮춘다고 보고되고 있다(Kurth et al., 2006; van Dam et al., 2008).

우리나라의 65세 이상 고령인구는 2020년에 전체 인구의 15.7%를 차지하였으며, 2025년에는 20.3%에 이르러 초고령사회로 진입할 것으로 예상된다(통계청, 2020). 평균 수명의 연장으로 이전의 인구구조에서 고령사회나 초고령사회로 변화하는 데 가장 크게 기여하는 연령층은 85세 이상 초고령 노인들이다. 국내의 경우 2015년 초고령 노인 인구수는 약 52만 명으로 전체 인구의 약 1%를 차지하였으며, 이는 10년 전과 비교하여 약 2배 이상 급증하였다(통계청, 2016b). 인구 고령화는 가족 차원에서 돌봄 부담이나 의료비용이 늘어날 뿐만 아니라 국가적 차원에서 소득보장이나 의료보장에 들어가는 사회적 비용이 급증하게 된다(Jeon, 2016).

노년기는 상실과 변화의 시기이며, 배우자 혹은 친구와 같은 가까운 사람과 이별하는 개인적 상실을 경험한다. 또한 권력, 경제적, 사회적 상실이나 고립과 소외를 초래하는 사회적 상실을 경험하는 시기이다(Park, 2022). 연령이 높아질수록 삶의 질에 부정적인 영향을 주는 것으로 보고되고 있다(Kim & Jung, 2019). 또한 노년기 적응의 어려움, 디스트레스 등으로 인해 신체적 및 심리적 건강의 급속한 악화를 수반할 수 있다(Park, 2022). 2016년 통계청 사망원인 데이터에 따르면 사망원인이 자살로 최종 진단된 자살사망률은 60대 36.9%, 70대 62.5%, 80대 이상 83.7%로, 초고령자가 가장 높은 것으로 나타났다(통계청, 2016a). 이를 통해 초고령 노인의 사망자수가 많으며, 자살위험성이 높다는 것을 보여준다. 그러나 국내의 노년기 삶의 만족도와 우울에 대한 연구는 대

부분 60~70대에 초점이 맞춰져 있으며(Gang & Ahn, 2022; Jeong & Lee, 2022), 초고령 노인(oldest-old)의 자살에 관한 연구는 거의 없다. 그러나 대부분의 연구는 초고령 노인을 연소노인(young-old)이나 고령노인(old-old)과 구별되는 연령집단으로 간주하기 보다는 고령인구의 연장선상으로 파악하고 있으며, 초고령 노인에게 대해 알려진 바가 거의 없다(Jeon, 2017).

평균수명의 연장으로 대한민국은 빠른 속도로 초고령 사회로 진입하고 있으며, 노년기가 연장되고 다양해지고 있음을 의미한다. 그러나 여전히 노년기 내 연령대별 분석에 대해 간과해온 경향이 있으며 초고령 노인을 대상으로 삶의 만족도와 우울에 대해 연구한 국내 논문은 거의 없다. 이로 인해 초고령 노인들의 정신건강 증진이나 예방을 위한 실천적 개입에 대한 함의를 제공하는 데 한계가 있다. 따라서 본 연구를 초고령 노인의 삶의 만족도와 우울에 영향을 주는 라이프스타일 요소를 분석하고자 한다.

II. 연구 방법

1. 연구 분석자료 및 대상자

본 연구는 고령화연구패널조사(Korean Longitudinal Study of Aging; KLoSA) 중 2018년에 시행된 제7차 자료를 사용하였다. KLoSA는 2006년부터 제주도를 제외한 지역에 거주하는 45세 이상 중고령자 중 일반 가구 거주자를 대상으로 표집 및 조사를 실시하고 있으며, 2018년 제7차 기본조사를 완료하였다(Korea Employment Information Service, 2022). 조사방법은 컴퓨터를 이용한 대면면접(computer-assisted personal interviewing)으로 진행되었으며, 면접원이 노트북이나 PDA를 지참하고 대상자에게 컴퓨터 화면에 나오는 질문을 읽어준 후 응답을 직접 입력하는 방식이다(Groves et al., 2011). 제7차 KLoSA의 참여자는 총 6,940명이었으며, 85세 이상 초고령자는 545명이었다. 이 중 결측치가 있는 대상자를 제외하고 최종 381명의 자료를 분석하였다. 본 연구는 연세대학교 미래캠퍼스 생명윤리심의위원회(institutional review board, IRB)로부터 윤리적 절차에 대한 승인을

받은 후 진행하였다(IRB 승인번호: 1041849-202210-SB-188-01).

2. 고령화연구패널조사(Korean Longitudinal Study of Aging, KLoSA)의 분석 변수

1) 일반적 특성 요인

일반적 특성은 성별, 연령, 교육수준, 그리고 거주지역을 사용하였다. '성별'은 남성 1, 여성 2로 구분하였으며, '연령'은 조사일 기준 응답자의 만 나이인 연속변수를 사용하였다. '교육수준'은 초졸 이하는 1, 중졸은 2, 고졸은 3, 대졸 이상은 4로 범주화하였으며, '거주지역'은 읍면부에 거주하는 경우 1, 중소도시에 거주하는 경우 2, 대도시에 거주하는 경우 3으로 범주화하였다.

2) 삶의 만족도와 우울

'삶의 만족도'는 동년배와 비교하였을 때 자신이 어느 정도 만족하고 있는가에 대한 질문에 0~100점 범위에서 10점 단위로 답한 답변을 사용하였다(코딩범위: 0~11). '우울'은 CESD-10-D (two shorter from of the Center for Epidemiologic Studies Depression scale)를 사용하였으며, 점수의 총점을 사용하였다. 점수는 최소 0점에서 최대 10점까지 범위 내에서 산출되었다(코딩범위: 0~10) (National Center for Mental Health, 2019).

3) 라이프스타일

(1) 신체활동

라이프스타일 요인은 신체활동, 식습관, 참여를 사용하였다. '신체활동'은 규칙적 운동 여부(일주일 1회 이상)에 대해 예/아니오(코딩범위: 0, 1)로 범주화하였다.

(2) 식습관

'식습관'은 어제와 그제개의 아침, 점심, 저녁식사의 유무로 식사한 횟수(총 6회)를 합산하여 1~5회는 불규칙적 식습관, 6회는 규칙적 식습관(코딩범위: 0, 1)으로 분류하였다.

(3) 참여

'참여'는 빈도와 다양성을 사용하였다. 빈도는 친한 사람들과 만나는 횟수를 기준으로 거의 볼 수 없음~거의 매일(코딩범위: 1~10)로 범주화하였으며, 다양성은 모임(종교, 친목, 여가/문화/스포츠, 동창회/향우회/종친회, 자원봉사, 정당/시민단체/이익단체, 기타)의 참여 횟수를 합산하여 분류하였다(코딩범위: 1~7).

3. 자료 분석 방법

본 연구는 자료 분석을 위하여 SPSS 26.0 (IBM Corp.)을 사용하였다. 기술통계를 이용하여 일반적 특성의 평균 및 빈도분석을 하였다. Pearson의 상관관계분석을 이용하여 삶의 만족도 및 우울과 라이프스타일 간의 상관관계 확인 및 다중공선성 분석을 시행하였다. 이후 다중회귀 분석을 이용하여 삶의 만족도 및 우울과 라이프스타일 요인별 상대적인 영향력을 확인하였다. 다중회귀분석은 많은 관련 독립변수 중에서 명확한 변수 선정을 위하여 단계선택(stepwise selection) 방법을 통해 분석하였고, 설명력 및 2차 다중공선성 진단 확인을 위하여 Durbin-Watson을 사용하였다. 유의수준은 $p < 0.05$ 으로 하였다.

III. 연구 결과

1. 연구대상자 일반적 특성

본 연구대상자는 총 381명이었다. 남성 124명(32.5%), 여성 257명(67.5%)이었으며, 연령은 85~89세 279명(73.2%), 90~94세 87명(22.8%), 95~99세 15명(3.9%)이었다. 최종학력수준은 초졸 이하가 304명(79.8%)으로 가장 많았으며, 중졸 및 고졸은 각 29명(7.6%), 대졸 이상은 19명(5.0%)이었다. 거주지역은 대도시에 134명(35.2%), 중소도시에 114명(29.9%), 읍면부에 133명(34.9%)이 거주하는 것으로 확인되었다. 우울 수준은 정상(0~2점) 256명(67.1%), 우울(3~10점) 125명(32.9%)으로 나타났다. 삶의 만족도의 경우 평균 55.5 ± 19.4 점으로 확인되었다(Table 1).

Table 1. General Characteristics of the Study Participants (N = 381)

Variable	Category	<i>n</i>	%
Sex	Male	124	32.5
	Female	257	67.5
Age group (yr)	85~89	279	73.2
	90~94	87	22.8
	95~99	15	3.9
Educational attainment	Elementary school	304	79.8
	Middle school	29	7.6
	High school	29	7.6
	College or university	19	5.0
Residential area	Metropolis	134	35.2
	Small and medium city	114	29.9
	Town and village	133	34.9
Depression	0	108	28.3
	1	21	5.5
	2	127	33.3
	3	27	7.1
	4	19	5.0
	5	19	5.0
	6	11	2.9
	7	17	4.5
	8	19	5.0
	9	9	2.4
	10	4	1.0
Life satisfaction	0	4	1.0
	10	7	1.8
	20	14	3.7
	30	44	11.5
	40	35	9.2
	50	63	16.5
	60	73	19.2
	70	82	21.5
	80	51	13.4
	90	7	1.8
	100	1	0.3
<i>Mean</i> ± standard deviation		55.5 ± 19.4	

2. 삶의 만족도 및 우울과 라이프스타일 요인 간의 상관관계

삶의 만족도 및 우울과 라이프스타일 요인 간의 상관관

계를 파악하기 위해 Pearson 상관분석을 실시하였다. 결과는 Table 2와 같다. 삶의 만족도의 경우 참여빈도($r = 0.300, p < 0.01$), 참여다양성($r = 0.215, p < 0.01$), 규칙적 식습관($r = 0.188, p < 0.01$), 그리고 신체활동($r =$

0.122, $p < 0.05$) 순으로 양적인 상관관계가 있는 것으로 확인되었다. 이를 통해 삶의 만족도가 높을수록 빈번하고 다양한 활동에 참여하며, 규칙적 식습관과 신체활동을 하는 것을 알 수 있다. 우울의 경우 삶의 만족도($r = 0.507$, $p < 0.01$), 참여빈도($r = 0.297$, $p < 0.01$), 규칙적 식습관($r = 0.218$, $p < 0.01$), 참여다양성($r = 0.181$, $p < 0.01$), 그리고 신체활동($r = 0.128$, $p < 0.05$) 순으로 양적인 상관관계가 있는 것으로 확인되었다. 이를 통해 우울감이 낮을수록 삶의 만족도가 높으며, 빈번하고 다

양한 활동에 참여하며, 규칙적 식습관과 신체활동을 하는 것을 알 수 있다.

3. 삶의 만족도에 영향을 미치는 라이프스타일 요인

삶의 만족도와 라이프스타일 요인 간의 영향력에 대한 단계 선택(stepwise selection) 분석 결과는 Table 3과

Table 2. Correlation Between Life Satisfaction and Depression and Lifestyle Factors

	PA	RD	FP	DP	LS	Dep
PA	1					
RD	0.059	1				
FP	0.157**	0.820	1			
DP	0.235**	0.094	0.509**	1		
LS	0.122*	0.188**	0.300**	0.215**	1	
Dep	0.128*	0.218**	0.297**	0.181**	0.507**	1

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$.

Dep: depression, DP: diversity of participation, FP: frequency of participation, LS: life satisfaction, PA: physical activity, RD: regular diet

Table 3. Lifestyle Factors Affecting Life Satisfaction

Variable	Unstandardized coefficient		Standardized coefficient	t (p)	TOL	VIF
	B	SE	β			
Dependent variable	29.265	3.973		7.366***		
Independent variable						
FP	1.615	0.258	0.299	6.262***	1.000	1.000
RD	17.303	3.739	0.221	4.627***	1.000	1.000
PA	0.070			1.442	0.972	1.029
DP	0.010			0.185	0.731	1.369
Sex	-0.081			-1.701	0.991	1.009
Age	-0.051			-1.061	0.984	1.017
EA	0.068			1.429	0.991	1.009
RA	-0.074			-1.548	0.985	1.016
	F (p)				29.978***	
	R				0.370	
	Adjusted R^2				0.132	
	Durbin-Watson				1.632	

*** $p < 0.001$.

DP: diversity of participation, EA: educational attainment, FP: frequency of participation, PA: physical activity, RA: residential area, RD: regular diet, SE : standard error, TOL: tolerance, VIF: variance inflation

같다. 삶의 만족도에 영향을 미치는 요인으로는 참여빈도($t = 6.262, p < 0.001$)와 규칙적 식습관($t = 4.627, p < 0.001$)이 통계적 유의성을 가지는 것으로 확인되었으며, 신체활동, 참여다양성, 우울은 통계적으로 유효하지 않아 제외되었다. 회귀 모형의 적합성은 $F = 29.978$ ($p < 0.001$)로 적합한 것으로 나타났으며, 수정된 R^2 값은 0.132로 13.2%의 설명력이 확인되었다. 참여빈도($\beta = 0.299, p < 0.001$)는 삶의 만족도에 정적(+)인 유의미한 영향을 미치며 친한 사람을 자주 만날수록 삶의 만족도가 높아지는 것으로 확인되었다. 규칙적 식습관($\beta = 0.221, p < 0.001$)은 삶의 만족도에 정적(+)인 유의미한 영향을 미치며 규칙적으로 식사할수록 삶의 만족도가 높아지는 것으로 확인되었다. 유의미하게 확인된 요인들에 대한 상대적 영향력을 비교한 결과는 참여빈도, 규칙적 식습관 순으로 영향력이 있는 것으로 확인되었다.

4. 우울에 영향을 미치는 라이프스타일 요인

우울과 라이프스타일 요인 간의 영향력에 대한 단계

선택(stepwise selection) 분석 결과는 Table 4와 같다. 우울에 영향을 미치는 요인으로는 참여빈도($t = 6.540, p < 0.001$), 규칙적 식습관($t = 4.061, p < 0.001$), 거주지역($t = 2.256, p < 0.001$)이 통계적 유의성을 가지는 것으로 확인되었으며, 신체활동, 참여다양성, 삶의 만족도는 통계적으로 유효하지 않아 제외되었다. 회귀 모형의 적합성은 $F = 20.113$ ($p < 0.001$)으로 적합한 것으로 나타났으며, R^2 값은 0.131로 13.1%의 설명력이 확인되었다. 참여빈도($\beta = 0.316, p < 0.001$)는 우울에 정적(+)인 유의미한 영향을 미치며 친한 사람을 자주 만날수록 우울은 낮아지는 것으로 확인되었다. 규칙적 식습관($\beta = 0.194, p < 0.001$)은 우울에 정적(+)인 유의미한 영향을 미치며 규칙적으로 식사하는 사람일수록 우울이 낮아지는 것으로 확인되었다. 거주지역($\beta = 0.109, p < 0.001$)은 우울에 정적(+)인 영향을 미치며 대도시에 거주할수록 우울이 낮아지는 것으로 확인되었다. 유의미하게 확인된 요인들에 대한 상대적 영향력을 비교한 결과는 참여빈도, 규칙적 식습관, 거주지역 순으로 영향력이 있는 것으로 확인되었다.

Table 4. Lifestyle Factors Affecting Depression

Variable	Unstandardized coefficient		Standardized coefficient	t (p)	TOL	VIF
	B	SE	β			
Dependent variable	4.744	0.594		7.989***		
Independent variable						
FP	0.229	0.035	0.316	6.540***	0.984	1.017
RD	2.041	0.503	0.194	4.061***	0.999	1.001
RA	0.339	0.150	0.109	2.256***	0.983	1.017
PA	0.045			0.903	0.929	1.076
DP	0.045			0.790	0.721	1.387
Sex	-0.079			-1.647	0.990	1.010
Age	0.044			0.909	0.985	1.015
EA	0.003			0.068	0.975	1.025
	F (p)				20.113***	
	R				0.370	
	Adjusted R^2				0.131	
	Durbin-Watson				1.659	

*** $p < 0.001$

DP: diversity of participation, EA: educational attainment, FP: frequency of participation, PA: physical activity, RA: residential area, RD: regular diet, SE : standard error, TOL: tolerance, VIF: variance inflation

Ⅳ. 고 찰

본 연구는 초고령자의 삶의 만족도 및 우울과 라이프스타일 요인 간의 상관관계를 분석하고, 삶의 만족도와 우울에 영향을 미치는 라이프스타일 요인을 알아보고자 하였다. KLoSA 참가자 중 85세 이상 초고령자 381명을 대상으로 하였으며, 상관관계 및 다중회귀분석을 실시하였다.

본 연구의 다중회귀분석 결과, 삶의 만족도에는 참여빈도와 규칙적 식습관이 유의미한 영향요인으로 확인되었다. 이는 고령자의 사회참여는 성공적 노화의 중요한 요소로서 참여가 높을수록 삶의 만족도가 높다는 선행 연구 결과를 지지한다(Kim, 2018). 노년기의 활동참여는 건강을 증진시키고, 사회관계 및 접촉할 기회를 제공하여 삶의 만족도를 유지 및 향상시킬 수 있다(Lee & Shin, 2016). 또한 여러 선행 연구들에서 사회참여의 경험들은 고령자의 우울 및 삶의 만족도에 긍정적인 영향을 미친다고 보고하고 있다(Hwang & Kwon, 2009; Kwon & Cho, 2000). 즉, 고령자들의 활동참여는 심리적 및 정서적 건강상태 증진에 긍정적인 도움이 된다(Bae, 2020). 반면, 삶의 만족도와 사회참여가 관련이 없음을 보고한 연구도 있다(Lee & Ko, 2015; Min, 2013). 앞서 상관관계 고찰의 내용과 같이 사회참여의 범주를 어떻게 볼 것인가에 따라 요인에 대한 영향력이 달라지는 것으로 사료된다. 사회참여 유형을 공적/사적 참여로 구분하기도 하며(Han et al., 2018), 종교활동, 여가생활 및 동창회, 친목회, 자원봉사, 정당/시민단체 참여, 경제활동 등을 포함하기도 한다(Korea Employment Information Service, 2022). 참여를 통합하여 하나의 변수로 영향력으로 분석하거나(Ju, 2011), 여러 참여 중 특정 참여의 삶의 만족도에 대한 영향력을 분석한 연구가 수행되었다(Moon et al., 2013). 이처럼 참여를 어떻게 구분하는가에 따라 삶의 만족도에 미치는 영향력이 다르기 나타날 수 있으며, 어떤 요인들과 삶의 만족도와의 관계를 규명하는가에 따라 분석 결과가 다르게 나타날 수 있다. 그럼에도 불구하고 다수의 연구에서 긍정적인 영향을 보고하고 있기에 고령자의 삶의 만족도 향상을 위해서는 참여가 중요함을 시사한다. 식습관의 경우 삶의 만족도에 규칙

적 식습관과 유의미한 영향을 미치는 요인으로 확인되었다. 이는 영양상태가 나쁜 고령자일수록 낮은 삶의 만족도가 보고된다(Yang, 2019)는 선행 연구 결과를 지지한다. 노년기의 특성상 신체기능을 저하로 건강을 유지하기 위해서는 영양관리가 매우 중요하며 삶의 질을 높인다(Hyun, 2020). 특히, 식습관은 인간이 생존하기 위해 영양물을 제공하는 음식물과 관련된 생활을 의미하며, 사회, 문화, 경제적 조건 등의 형태에 의해 영향을 받게 된다(Nam et al., 2013). 따라서 초고령자의 보다 나은 식습관으로 전환하기 위해서는 식습관과 더불어 다양한 조건을 반영한 다면적인 평가 및 중재를 통해 변화시키는 것이 중요하다.

본 연구의 다중회귀분석 결과, 우울에는 참여빈도, 규칙적 식습관, 그리고 거주지역이 유의미한 영향요인으로 확인되었다. 노년기에는 신체적 기능의 감퇴, 질병의 증가, 그리고 사회관계망의 위축 등을 겪게 되면서 우울 수준이 높아지게 된다(de Wit et al., 2010). 노인실태조사에서는 전체 노인의 13.5%가 우울증상을 나타내고 있는 것으로 나타났고, 고령일수록 우울 증상이 더 심하게 나타났다(Lee et al., 2020). 노인의 우울 수준은 사회적 관계, 환경 등과 같은 요인에 따라 변화되며, 이러한 요인 중 하나가 여가 활동 참여이다(Cho, 2020; Chun & Kim, 2021). 노년기의 활동 참여는 노화현상을 늦추며 체력저하를 예방한다(Koskinen & Leinonen, 2022). 또한 참여는 불안이나 우울 증상 및 스트레스의 감소 등 정신 건강에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보고된다(Bone et al., 2022; Cho & Hur, 2020). 따라서 고령자의 우울을 감소시키기 위해서 참여를 독려할 필요가 있다. 식습관의 경우 신체적 건강뿐만 아니라 우울과 같은 정신건강에 영향을 미친다고 보고되고 있다(de Wit et al., 2010). 아침 식사 빈도가 높을수록 우울이 낮으며(Cho & Park, 2021), 영양상태가 좋지 않을수록 우울에 대한 높은 위험도를 보고한다(Park & Suh, 2007). 이렇듯 노인의 우울은 식습관과 밀접한 관련성이 있으며, 노인의 우울을 감소시키기 위해서 개인의 건강한 식습관이 우울을 감소시킬 수 있음을 확인하였다.

연소노인들은 라이프스타일 요인인 신체활동, 규칙적 식습관, 참여가 모두 중요하다고 알려져 있으나 초고령자를 대상으로 한 본 연구에서는 건강한 라이프스타일을

위해서는 참여와 규칙적 식습관이 삶의 만족도와 우울에 영향을 미치는 공통적인 영향요인으로 확인되었다. 이는 연소노인과 차이를 보이는 부분으로 초고령자의 건강한 라이프스타일을 위한 중재에서는 참여와 규칙적 식습관의 중요성이 더욱 강조되어야 함을 시사한다. 노화는 시간의 흐름에 따라 발생하는 자연스러운 현상이며, 신체적, 심리적, 사회적 측면에서 신체가 쇠퇴해가는 단계를 의미한다(De Winter, 2015). 이러한 과정에서는 제지방량 감소에 따른 기초대사 감소, 식욕 감퇴, 연하 작용의 장애에 따른 음식 섭취량 감소로 인한 영양 결핍 위험도가 높아지며, 영양상태는 인체의 건강 상태를 결정하는 주요한 인자 중 하나로서 노년기의 만성질환 및 인지적, 심리적, 사회적 장애와도 밀접한 관련이 있다고 보고된다(Brownie, 2006; Engelheart & Brummer, 2018). 삶의 만족도 및 우울 개선을 위해서는 식습관 상태를 확인하여 필요할 경우 개선방안과 교육을 실시하는 것이 중재의 방향임을 시사한다. 활동 참여는 노년기의 정신적 및 심리적 문제를 완화시키고, 만성화된 무로함을 벗어날 수 있게 하는 효과적이다(Lee, 2004). 2020년 보건복지부의 노인실태조사에 따르면, 고령자의 80.3%가 여가 및 문화활동을 하고 있으며, 일일 평균 6.6시간을 소비하는 것으로 조사되었다(Lee et al., 2020). 이 중 4.6시간이 TV 시청으로 확인되었다. 즉 대부분의 고령자가 TV를 시청하면서 시간을 보내는 것으로 확인되었다. 본 연구 결과에 따르면 참여는 삶의 만족도와 우울에 영향을 미치는 요인으로 확인되었으며, 이를 위해서는 참여할 수 있는 다양한 프로그램을 지원하는 제도적 장치를 마련하거나 바우처 제도를 도입하는 등의 고령자의 다양한 활동 참여를 위한 서비스 및 환경을 개선하는 것이 중요하다. 또한, 참여를 활성화시킬 수 있는 지역사회 내 인프라 구축이 필요하다. 고령자의 성별, 교육 수준, 연령 등 다양한 특성의 대상자들의 요구를 포괄적으로 수용할 수 있는 참여 시설을 확보하는 것이 필요하다. 공공시설뿐만 아니라 참여 프로그램을 수행할 수 있는 단체를 지원하여 고령자들의 참여를 독려할 수 있는 인프라가 모색되어야 할 것이다.

WHO는 고령화로 인한 문제를 해결하기 위하여 다양한 건강전문가와 지역사회가 협력하도록 권고하고 있다(WHO, 2022). 미국, 영국, 호주에서는 건강 관련 서비

스에 대한 요구도를 충족시키고, 사회적 비용을 감소시키기 위해 지역사회 내 작업치료 서비스를 확대하고 있다(Korean Association of Occupational Therapists, 2018). 작업치료의 영역은 국제 기능, 장애 및 건강에 대한 분류(International Classification of Functioning, Disability and Health)에 근거하여 의사, 간호사, 사회복지사 등 다양한 분야의 전문가와 함께 지역사회 건강관리가 가능하다(American Occupational Therapy Association, 2020). 지역사회 내의 초고령자 정신건강 증진 및 예방을 위한 전문가로서 포괄적인 서비스를 제공해 줄 수 있다.

본 연구의 제한점은 다음과 같다. 첫 번째, 본 연구의 참여자 중 67.5%가 여성으로 대부분을 차지하였다. 이러한 성별의 편향된 분포는 결과 해석에 영향을 미칠 수 있다. 성별에 따른 라이프스타일의 요인의 차이가 존재할 수 있기에 향후 연구에서는 균형 있는 성별 분포를 확보하거나 성별을 통제하여 대상자의 성별에 따른 영향요인의 차이가 고려되어야 한다. 두 번째, 본 연구의 참여자 중 79.8%가 초졸이었다. 이는 현재보다 교육을 받을 기회가 상대적으로 제한되었던 과거의 국내 상황을 반영한 결과라고 할 수 있다. 그러나 점차 고학력자가 초고령자로 진입하고 있는 점을 감안하였을 때, 향후 연구에서는 다양한 교육 수준의 대상자를 포함하여 연구를 확장함으로써 일반화 가능성을 높일 수 있을 것이다. 세 번째, 본 연구는 횡단적 연구 설계로 분석되었으며, 변수들의 인과관계를 명확히 확인하는 데 제한이 있다. 이에 대하여 향후 시간적 선후관계 파악을 위한 종단적 연구를 제안한다. 마지막으로, 본 연구의 분석에 사용된 자료는 2018년 자료이다. 코로나로 인한 팬데믹 상황임을 고려하였을 때, 코로나 이후의 초고령자의 변화된 라이프스타일에 대해 알아보는 추가적 연구가 필요하다.

V. 결 론

본 연구는 초고령자의 삶의 만족도 및 우울과 라이프스타일 요인 간의 상관관계를 분석하고, 삶의 만족도와 우울에 영향을 미치는 라이프스타일 요인을 알아보고자 하였다. 다중회귀분석 결과로 삶의 만족도에는 참여빈도

와 규칙적 식습관이 유의미한 영향을 미치는 요인으로 확인되었으며, 우울은 참여빈도, 규칙적 식습관, 그리고 거주지역이 유의미한 영향을 미치는 요인으로 확인되었다. 현대 사회에서 수명의 증가와 고령화 시대의 진입이라는 점을 고려하였을 때, 초고령자를 위한 맞춤형 라이프스타일 중재 프로그램을 통한 삶의 질 향상의 중요성이 요구된다. 본 연구는 초고령자를 대상으로 삶의 만족도와 우울에 영향을 미치는 라이프스타일 요인을 분석한 것에 의의가 있으며, 초고령자들의 정신건강 증진 및 예방을 위한 기초자료로 활용될 것이다.

References

- 통계청. (2016a). *사망원인통계*. 통계청.
- 통계청. (2016b). *인구동향조사*. 통계청.
- 통계청. (2020). *2020 고령자 통계*. 통계청.
- American Occupational Therapy Association. (2020). Occupational therapy practice framework: Domain and process: Fourth edition. *The American Journal of Occupational Therapy*, 74(Suppl 2), 7412410010p1-7412410010p87. doi:10.5014/ajot.2020.74S2001
- Bae, J. (2020). Health and social participation characteristics of Korean older adults: Focusing on the older adults who participate in the senior social activities and job program of the ministry of health and welfare. *The Korean Journal of Physical Education*, 59(3), 291-301. doi:10.23949/kjpe.2020.5.59.3.291
- Bone, J. K., Bu, F., Fluharty, M. E., Paul, E., Sonke, J. K., & Fancourt, D. (2022). Engagement in leisure activities and depression in older adults in the United States: Longitudinal evidence from the health and retirement study. *Social Science & Medicine*, 294, 114703. doi:10.1016/j.socsci.med.2022.114703
- Brownie, S. (2006). Why are elderly individuals at risk of nutritional deficiency? *International Journal of Nursing Practice*, 12(2), 110-118. doi:10.1111/j.1440-172X.2006.00557.x
- Cho, I. (2020). A study of the effect of leisure time activities on depression among elderly. *Journal of the Korea Convergence Society*, 11(11), 269-282. doi:10.15207/JKCS.2020.11.11.269
- Cho, M., & Hur, J. (2020). A study on effect of regular leisure activities on health-related quality of life (SF-36) in the elderly: Physical leisure activities. *Korean Journal of Leisure, Recreation & Park*, 44(4), 77-91. doi:10.26446/kjlrp.2020.12.44.4.77
- Cho, E. A., & Park, S. H. (2021). Correlation between depression, body awareness, physical activity, eating habits and oral health in older women. *Journal of Society of Occupational Therapy for the Aged and Dementia*, 15(1), 15-22. doi:10.34263/jsotad.2021.15.1.15
- Chun, M., & Kim, J. H. (2021). A study of changes in influencing factors on depression and the characteristics of elderly living alone in urban and rural areas. *Journal of Public Policy Studies*, 38(1), 341-369. doi:10.33471/ILA.38.1.14
- De Winter, G. (2015). Aging as disease. *Medicine, Health Care, and Philosophy*, 18(2), 237-243. doi:10.1007/s11019-014-9600-y
- de Wit, L. M., Fokkema, M., van Straten, A., Lamers, F., Cuijpers, P., & Penninx, B. W. (2010). Depressive and anxiety disorders and the association with obesity, physical, and social activities. *Depression and Anxiety*, 27(11), 1057-1065. doi:10.1002/da.20738
- Engelheart, S., & Brummer, R. (2018). Assessment of nutritional status in the elderly: A proposed function-driven model. *Food & Nutrition Research*, 62, doi:10.29219/fnr.v62.1366
- Gang, M., & Ahn, Y. (2022). Related factors of suicide ideation in elderly people with diabetes mellitus living alone in rural area. *Journal of*

- Industrial Convergence*, 20(10), 79-86. doi: 10.22678/JIC.2022.20.10.079
- Groves, R. M., Fowler Jr, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E., & Tourangeau, R. (2011). *Survey methodology*. John Wiley & Sons.
- Han, C. M., Bae, S. K., & Kim, H. S. (2018). The effect of social relations of the elderly on subjective health perception. *GRI Review*, 20(2), 31-52.
- Hwang, J., & Kwon, S. (2009). The relation between the participation in social activity and cognitive function among middle-aged and elderly population. *Journal of the Korean Gerontological Society*, 29(3), 971-986.
- Hyun, E. (2020). The impact of active aging of the elderly on life satisfaction in the aged society. *Journal of Humanities and Social Sciences* 21, 11(4), 1491-1506. doi:10.22143/HSS21.11.4.105
- Jeon, H. S. (2016). The trajectory of suicide risk and its related factors among the oldest-old: Depression or social security.? *Journal of Social Science*, 55(2), 209-233. doi:10.22418/JSS.2016.12.55.2.209
- Jeon, H. S. (2017). The trajectory of depressive symptoms among the oldest-old: Focusing on gender difference. *Korean Journal of Health Education and Promotion*, 34(1), 25-34. doi: 10.14367/kjhep.2017.34.1.25
- Jeong, Y., & Lee, Y. (2022). The double mediating effects of family support and happiness on meaning in life and suicidal ideation among the Korean baby boomers. *Korean Journal of Research in Gerontology*, 31(2), 95-112. doi: 10.25280/kjrg.31.2.4
- Ju, K. H. (2011). Activity level of social participation and quality of life among the elderly in Korea: Focusing on gender and age differences. *Korean Journal of Social Welfare Studies*, 42(2), 5-39. doi:10.16999/kasws.2011.42.2.5
- Kim, S. B. (2018). A study on the effect of social participation activities on the level of life satisfactions among the elderly: Focusing on mediating effect of depression. *Journal of Humanities and Social Sciences* 21, 9(3), 115-129. doi:10.22143/HSS21.9.3.10
- Kim, S. A., & Jung, H. S. (2019). The determinants of life satisfaction in different age groups and their policy implications. *Health and Welfare Policy Forum*, (270), 95-104. doi:10.23062/2019.04.9
- King, D. E., Mainous, A. G., III, Carnemolla, M., & Everett, C. J. (2009). Adherence to healthy lifestyle habits in US adults, 1988-2006. *The American Journal of Medicine*, 122(6), 528-534. doi:10.1016/j.amjmed.2008.11.013
- Korea Employment Information Service. (2022). *Introduction of KLoSA (Korean Longitudinal Study of Aging)*. Retrieved from <https://survey.keis.or.kr/eng/klosa/klosa01.jsp>
- Korean Association of Occupational Therapists. (2018). *Community care and occupational therapy*. Elderly Information Center.
- Koskinen, V. K., & Leinonen, E. A. (2022). Leisure adjustments of older finnish adults during the early stages of the COVID-19 pandemic. *International Journal of the Sociology of Leisure*, 5, 373-391. doi:10.1007/s41978-022-00113-x
- Kurth, T., Moore, S. C., Gaziano, J. M., Kase, C. S., Stampfer, M. J., Berger, K., & Buring, J. E. (2006). Healthy lifestyle and the risk of stroke in women. *Archives of Internal Medicine*, 166(13), 1403-1409. doi:10.1001/archinte.166.13.1403
- Kwon, J. D., & Cho, J. Y. (2000). A study of factors influencing the life satisfaction of the aged. *Journal of the Korea Gerontological Society*, 20(3), 61-76.
- Lee, D. S. (2004). *The effects of participations in*

- leisure activities on perceived quality of life for the elderly (Doctoral dissertation). Gyeongsang National University. Retrieved from https://m.riss.kr/search/detail/ssoSkipDetailView.do?p_mat_type=be54d9b8bc7cdb09&control_no=c443a6f9f8a7b0a1ffe0bdc3ef48d419#redirect
- Lee, Y. K., Kim, S. J., Hwang, N. H., Lim, J. M., Joo, B. H., Namkung, E. H., Lee, S. H., Jeong, K. H., Kang, E. N., & Kim, K. R. (2020). *2020 National survey of older Korean* (Policy report 2020-35). Retrieved from Ministry of Health and Welfare, Korea Institute for Health and Social Affairs. <http://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/38157>
- Lee, M. H., & Ko, J. E. (2015). The impact of social capital on aging problems among community-living older adults. *Journal of Korean Social Welfare Administration*, 17(3), 85-110.
- Lee, H. S., & Shin, W. W. (2016). The effect of types of leisure activities of elders on life satisfaction. *Journal of Culture Industry*, 16(3), 157-165.
- Lee, J., Um, K., Futouy, Y., & Nakajima, K. (2012). The relationship between health-related lifestyles and living functions of Korean and Japanese elders. *Health and Social Welfare Review*, 32(1), 58-88.
- May, A. M., Struijk, E. A., Fransen, H. P., Onland-Moret, N. C., de Wit, G. A., Boer, J. M., van der Schouw, Y. T., Hoekstra, J., Bueno-de-Mesquita, H. B., Peeters, P. H., & Beulens, J. W. (2015). The impact of a healthy lifestyle on disability-adjusted life years: A prospective cohort study. *BMC Medicine*, 13, 39. doi:10.1186/s12916-015-0287-6
- Min, J. (2013). Effect of social engagement on self-rated health trajectory among Korean older adults. *Health and Social Welfare Review*, 33(4), 105-123. doi:10.15709/hswr.2013.33.4.105
- Moon, B. Y., Lee, K. H., & Moon, H. Y. (2013). Relationship between the elderly's leisure activities, leisure satisfaction and life satisfaction. *Journal of Tourism and Leisure Research*, 25(5), 273-287.
- Nam, H., Myung, C., & Park, Y. (2013). A study on the dietary behaviors of female baby boomers and the needs for future perspectives of dietary life. *Korean Journal of Food and Nutrition*, 26(3), 895-908. doi:10.9799/ksfan.2013.26.4.895
- National Center for Mental Health. (2019). *2019 Standard guidelines for mental health examination tools and use*. Retrieved from https://www.ncmh.go.kr/mentalhealth/board/boardView.do;jsessionid=Gkr6QwnkWK0jXzZkHqaa8Okw4Rx2l01y1bRBdASWUpBO9sp8JqTIGIM5VuYaB0Hp.mohwwas2_servlet_engine1?no=8535&fno=106&gubun_no=&menu_cd=04_02_00_03&bno=&pageIndex=&search_item=&search_content=
- Park, C. (2022). Factors affecting life satisfaction by gender and age of middle-aged and elderly. *Journal of the Korean Gerontological Society*, 42(4), 855-871. doi:10.31888/JKGS.2022.42.4.855
- Park, Y. H., & Suh, E. E. (2007). The risk of malnutrition, depression, and the perceived health status of older adults. *Journal of Korean Academy of Nursing*, 37(6), 941-948. doi:10.4040/jkan.2007.37.6.941
- Park, K. H., Won, K. A., & Park, J. H. (2019). Systematic study on the multifaceted lifestyle assessment tools for community-dwelling elderly: Trend and application prospect. *Therapeutic Science for Rehabilitation*, 8(3), 7-29. doi:10.22683/tsnr.2019.8.3.007
- World Health Organization. (2022). *Noncommunicable diseases*. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases>

- Yang, K. M. (2019). Effects of nutritional status, activities daily living, instruments activities daily living, and social network on the life satisfaction of the elderly in home. *Journal of the Korean Applied Science and Technology*, 36(4), 1472-1484. doi:10.12925/jkocs.2019.36.4.1472
- Ziglio, E., Currie, C., & Rasmussen, V. B. (2004). The WHO cross-national study of health behavior in school-aged children from 35 countries: Findings from 2001-2002. *Journal of School Health*, 74(6), 204-206. doi:10.1111/j.1746-1561.2004.tb07933.x

Abstract

Analysis of Lifestyle Factors Affecting Life Satisfaction and Depression Among the Oldest-old: Using the Korean Longitudinal Study of Aging Data

Kim, Ah-Ram*, Ph.D., O.T., Park, Ji-Hyuk**, Ph.D., O.T.

*Yonsei New-normal Lifestyle Research Center, Yonsei University, Postdoctoral Researcher

**Dept. of Occupational Therapy, College of Software and Digital Healthcare Convergence,
Yonsei University, Professor

Objective: This study examined the correlation between life satisfaction, depression, and lifestyle (physical activity, eating habits, participation frequency, and participation diversity) among the oldest-old in Korea, and analyzed lifestyle factors that affect life satisfaction and depression.

Methods: The independent variables analyzed in this study were physical activity, regular eating habits, participation frequency, and participation diversity as lifestyle factors, and dependent variables were life satisfaction and depression. For analysis, correlation analysis and multiple regression analysis were performed through SPSS.

Results: As a result of multiple regression analysis, it was confirmed that participation frequency ($t = 6.262, p < 0.001$) and regular diet ($t = 4.627, p < 0.001$) had statistical significance as factors influencing life satisfaction, and depression was identified as a factor influencing participation frequency ($t = 6.540, p < 0.001$) and regular diet ($t = 4.061, p < 0.001$), which had statistical significance.

Conclusion: This study identified lifestyle factors affecting life satisfaction and depression among the oldest-old in Korea. Therefore, based on the results of this study, a lifestyle-based multifaceted intervention program is needed to improve life satisfaction and depression in the oldest-old in Korea.

Key words: Depression, Life satisfaction, Lifestyle, Oldest-old